Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5232739-26.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS SACCHET

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

PATRÍCIA DE OLIVEIRA FREITAS SACCHET ingressou com ação ordinária em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MÉDICA LTDA**, narrando, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré e que sofre de dermatite atópica há 22 anos. Realizou diversos tratamentos tópicos e sistêmicos, com pouco sucesso, inclusive com ciclos de antibióticos, fototerapia e corticoides. Diante do seu quadro clínico, a médica que acompanha seu tratamento prescreveu o uso do medicamento DUPILUMABE, o qual possui custo extremamente alto. Em setembro de 2021, iniciou tratamento com a medicação fornecida gratuitamente pelo fabricante e apresentou surpreendente melhora. No entanto, houve a negativa de cobertura pela parte ré sob a justificativa de que o tratamento prescrito não está previsto no rol da ANS e também porque a Lei n.º 9.656/98 exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Invocou dispositivos legais sobre a matéria e colacionou jurisprudência. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à parte ré o fornecimento do medicamento DUPIXENT, na forma prescrita pela médica. Ao final, pugnou pela procedência da ação para, tornando definitiva a tutela de urgência postulada, reconhecer seu direito ao medicamento prescrito. Postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e apresentou documentos.

Concedida a gratuidade da justiça à autora, bem como a tutela de urgência postulada (evento 4, DESPADEC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 18, CONT1), impugnando, preliminarmente, o valor atribuído à causa. No mérito, defendeu a legitimidade da negativa de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar. Invocou o disposto no artigo 17, VI, da Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS. Afirmou que não está obrigada pelo contrato a prestar cobertura assistencial além daquela devidamente pactuada. Mencionou dispositivos legais sobre a matéria e colacionou jurisprudência. Ao final, pugnou pelo julgamento de improcedência da ação e anexou documentos.

Sobreveio réplica, ocasião em que a parte autora refutou a tese defensiva, reiterando o pleito de procedência (evento 21, RÉPLICA1).

Rejeitada a impugnação ao valor atribuído à causa (evento 23, DESPADEC1).

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de outras provas, nada requereram.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Não havendo interesse na produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Na ausência de preliminares pendentes de apreciação, passo de imediato ao exame da questão de fundo.

De início, imperativo consignar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, porque envolvem relação de consumo. Assim dispõe a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

No caso, a existência de relação contratual entre as partes, além de incontroversa, está demonstrada pelos documentos anexados aos autos.

Embora o laudo médico anexado pela parte autora no evento 1, LAUDO10 descreva, pormenorizadamente, a necessidade de utilização do medicamento DUPILUMABE ao seu tratamento, o contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária estabeleceu, expressamente, a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Vejamos:

> **EXCLUSÕES DE COBERTURA**
>
> **XV. EXCLUSÕES DE COBERTURA**
>
> **Cláusula Quadragésima Terceira. Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subsequentes, os seguintes procedimentos:**

VII - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta do profissional de saúde habilitado, ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoa físicas em farmácias de acesso público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatório, urgência e emergência);

Acerca dos medicamentos e insumos de uso domiciliar, a Lei n.º 9.656/98 incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico oral (e correlacionados), à medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, *in verbis:*

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *[...]*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

Cabe salientar que o caso não se enquadra nas exceções previstas no artigo 12 da Lei n.º 9.656/98, que assim dispõe:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *[...]*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *[...]*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*

Ademais, assim dispôs a Agência Nacional de Saúde Suplementar na Resolução Normativa n.º 465 de 2021:

> *Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*
>
> *Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:*
>
> *[...]*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;*

De se ressaltar que a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do STJ que tratam da matéria (RESP n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) é no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como previsto no artigo 10 da Lei n.º 9656/98, excetos os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal, não sendo essa a hipótese dos autos.

Conclui-se, portanto, que o plano de saúde demandado não está obrigado a fornecer o medicamento postulado.

Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em casos análogos:

> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAPRECIAÇÃO. **PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS DUPILUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICOS. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE FORNECIMENTO AFASTADO.** SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. II. **É LÍCITA A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DA UNIDADE DE SAÚDE**, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS, A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM, NA FORMA DOS ARTS. 10, VI, E 12, I, "C", E II, "G", DA LEI N° 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ. III. NO CASO, O MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE É DE USO DOMICILIAR E PODE SER ADMINISTRADO PELO PRÓPRIO PACIENTE, SEM AJUDA DE PROFISSIONAL HABILITADO. IV. **CONSIDERANDO QUE O MEDICAMENTO EM QUESTÃO NÃO TÊM FINS ANTINEOPLÁSICOS OU CORRELACIONADOS, NÃO SE TRATA DE MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ROL DA ANS PARA O FIM***

> ***DOMICILIAR, NÃO É DEVIDA A COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.*** *V. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CONSIDERANDO O DECAIMENTO INTEGRAL DA AUTORA EM SUAS PRETENSÕES. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (Apelação Cível, Nº 50044614620208210008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-06-2023) grifei.*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.* ***COBERTURA PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.*** *ROL DA ANS, DE REGRA, TAXATIVO.* ***AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA.*** *1. A Lei nº 9.656/98, quanto aos medicamentos e insumos de uso domiciliar, incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico oral (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 2. A orientação jurisprudencial no sentido de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde" (AgInt no REsp 1.890.823/SP, 4ª Turma, DJe 28/4/2022). No mesmo sentido: REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, DJe 4/5/2021). 3. O medicamento* ***Dupilumabe (Dupixent)*** *enquadra-se na referida exclusão, pois não se destina a uso hospitalar ou ambulatorial, mas domiciliar, conforme mostra a bula, constituindo apenas uma faculdade do paciente a administração por profissional de saúde em ambiente ambulatorial. 4. Portanto,* ***o medicamento pleiteado se encaixa nas hipóteses de exceção expressamente previstas no 10 da Lei nº 9.656/98 para a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, já que pode ser adquirido diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica.*** *NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50049348920218210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-03-2023) grifei.*

Portanto, não vislumbro abusividade na negativa de cobertura feita pela demandada, razão pela qual não prospera o pedido de obrigação de fazer.

Isso posto, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido formulado por PATRÍCIA DE OLIVEIRA FREITAS SACCHET em desfavor de UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MÉDICA LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência concedida no evento 4, DESPADEC1.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, no entanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Em caso de interposição de recurso por qualquer dos litigantes, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remeta-se ao Tribunal competente para apreciação.

Na hipótese, se a Serventia observar eventual alegação de preliminar em contrarrazões, deverá ser intimada a parte apelante para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto pelo art. 1.009, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SCHWARTZ MANICA, Juiz de Direito**, em 28/7/2023, às 13:35:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10043070901v11** e o código CRC **ad3650a0**.